고혈압 약, 미루지 말아야 하는 이유

혈압약은 혈압 숫자가 아니라 혈압이 만드는 합병증(뇌·심장·신장·눈·대혈관)을 막기 위해 먹습니다. 운동·식이·체중관리는 약과 함께 가는 동반자입니다.

왜 지금 시작해야 하나요? (Key Numbers)

치료 안 한 고혈압 · 뇌졸중 위험
2~3배
정상혈압 대비

위 혈압 10 낮추면 · 심혈관 사건
약 20%↓
수축기 10mmHg · 여러 연구 종합

위 혈압 10 낮추면 · 뇌졸중
약 27%↓
같은 분석 · 심부전은 약 28%↓

혈압을 방치하면 — 증상 없이 진행되는 5대 합병증



합병증	어떻게 진행하나요
뇌졸중 · 혈관성 치매	갑자기 마비·언어장애·의식소실 — 고혈압이 가장 큰 위험인자
고혈압성 망막병증	시야 흐림·출혈 — 본인은 못 느끼고 안저검사로 발견
심근경색 · 심부전	흉통·호흡곤란 — 심장 벽이 두꺼워지고 굳음
만성콩팥병 · 투석	단백뇨·기능 저하 → 투석 (당뇨와 함께 양대 원인)
대동맥 박리 · 동맥류	혈관 벽이 찢어지는 응급 — 갑작스러운 가슴·등 통증

심전도가 정상이어도 심장벽 비대를 배제할 수 없고, 심전도만의 비대도 추적이 필요합니다. 아산 28회 연수강좌 — 흔한 심전도 이상, 놓치지 말아야 할 핵심 포인트(남기병)

흔한 오해 vs 바로 알기

자주 듣는 오해	바로 알기
"지금 증상 없으니 괜찮다"	합병증은 **증상 없이** 진행합니다.
"운동·영양제로 잡을 수 있다"	140/90 이상이 계속되면 **생활관리만으로는 부족한 경우가 많습니다.**
"평생 먹어야 하니 늦게 시작하겠다"	**미룬 기간만큼 혈관 손상이 쌓입니다.** 용량은 진료에서 함께 조정합니다.
"약이 신장·간에 부담을 준다"	오히려 **신장을 보호**합니다. 치료하지 않는 쪽이 더 위험합니다.

근거 있는 접근 · FACT

1. 약이 필요하다고 판단되면 **미루지 않고 생활관리와 함께** — 위험이 낮은 1기 고혈압은 생활관리를 먼저 해 보기도 합니다
2. 가정혈압 매일 측정 — 아침·자기 전 (재는 법: 「혈압, 이렇게 재야 정확합니다」)
3. 저염식 + 유산소 30분 + 체중 5kg 감량 — 약 효과 ↑
4. 3개월마다 정기 진료 — 약 조정 + 합병증 조기 발견

약은 언제까지 먹나요? — 조정 로드맵

0~3개월 · 함께 시작	3~12개월 · 목표 유지 확인	1년 이상 · 유지하며 조정
약으로 혈압을 안정시키고 가정혈압 측정·식이·운동을 습관으로 만듭니다.	가정혈압 기준은 대부분 **135/85 미만**. 당뇨·콩팥병·심뇌혈관질환이 있으면 담당 의사가 더 낮게 정합니다.	대부분 약을 이어 갑니다. 혈압이 충분히 낮게 유지되면 용량 조정을 의사와 상의합니다. **스스로 줄이거나 끊지 않습니다.**

두 성분을 한 알로 묶어 복용 부담을 줄일 수 있고, 고령·노쇠에서는 단독요법을 고려합니다. 아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한고혈압학회 고혈압 진료지침 (2022) · 2023 ESH · 2025 AHA/ACC 고혈압 지침 · Ettehad 등, Lancet 2016 (혈압 강하 효과 메타분석)

함께 보기 — 이미 약을 드시는 분: 「혈압약, 먹었다 말았다 하면 안 되는 이유」
edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/htn-daily-adherence/

본 자료는 일반 안내이며 개인의 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.

복용 중 안내 | 집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/htn-why-start/